当院におけるパニック値報告後対応の可視化に向けた運用体制の構築

◎羽田野 美奈子[1)]、後藤 真美[1)]、後藤 幸雄[1)]、森本 剛史[1)]、菊地 良介[2)]
社会医療法人 蘇西厚生会 松波総合病院[1)]、岐阜大学医学部附属病院[2)]

【背景】パニック値は生命に危険を及ぼす可能性のある異常値であり、迅速かつ適切な対応を要する。当院では従来、パニック値発生時に依頼医師へ電話報告を行っていたが、報告後の対応内容が電子カルテに記載されているかの確認は実施していなかった。今回、『臨床検査「パニック値」運用に関する提言書』への対応及びISO15189認定取得を契機として、臨床検査技師による報告後確認体制を整備した。

【目的】パニック値報告後の医師対応を可視化することを目的に、電子カルテ記載確認を含む新たな報告体制を構築し、その運用内容と課題を検討した。

【運用変更】従来20項目を対象としていたパニック値報告のうち、医療安全管理室担当医師と協議の上、電子カルテ記載確認の対象を、致死的となる可能性がある緊急性の高いK、Glu、PT-INR、Hb、PLTの5項目に限定し、併せてKの報告上限値を5.7mEq/Lから6.0mEq/Lへ変更した。対象項目について、臨床検査技師が依頼医師へ電話報告後、電子カルテ上で処置内容の記載有無を確認し、Clinical Supporting Systemに記録した。さらに、医療安全管理室担当医師が処置内容の妥当性を確認する運用とした。

【結果】新体制導入後、電子カルテ記載確認の対象件数は月平均約50件となり、従来のパニック値報告件数（月平均約200件）の約1/4であった。これにより、検査業務への過度な負担を回避しつつ、パニック値報告後の医師対応及びカルテ記載状況を把握可能な体制が整備された。

【考察】対象項目を限定することで、日常検査業務に配慮した現実的な運用が可能となった。一方で、電子カルテの記載様式は医師間で差異があり、処置内容の確認に時間を要する症例も認めた。今後は記載様式の標準化、記載率の集計・評価を進め、医療安全委員会と連携しながら、パニック値対応の質向上に努めたい。

連絡先：058-388-0111　内線 2235